

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE ACTITUDES HACIA LA ALIMENTACIÓN — FORMA COMPLETA (EAT-40)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Exhaustiva de Anorexia Nerviosa, Bulimia y Conductas Alimentarias Anómalas

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Actitudes hacia la Alimentación - Versión de 40 Ítems (EAT-40).
Nombre Original (Inglés)	<i>Eating Attitudes Test - 40 Item Form (EAT-40)</i>
Autores Originales	David M. Garner y Paul E. Garfinkel (1979), University of Toronto.
Adaptaciones Españolas	Castro, Toro, Salamero y Guimerá (1991); Toro, Castro, García et al. (1989); Guimerá y Torrubia (1987).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación monográfica de actitudes y conductas alimentarias.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 40 reactivos politómicos de 6 opciones corregidos asimétricamente (0, 0, 0, 1, 2, 3).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 12 años). Consultas clínicas especializadas, hospitales e investigación.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para investigación clínica y práctica asistencial sin fines comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO ORIGINAL DE GARNER

El EAT-40 representa el instrumento psicométrico fundacional y de referencia histórica diseñado por Garner y Garfinkel (1979) para cuantificar los rasgos cognitivos y conductuales característicos de la **Anorexia Nerviosa**. Su desarrollo supuso un salto metodológico decisivo al estandarizar operacionalmente el miedo mórbido al sobrepeso, la distorsión perceptiva de la delgadez y los rituales alimentarios obsesivos.

Aunque la versión reducida de 26 reactivos es más empleada en cribados poblacionales masivos por su rapidez, el EAT-40 original mantiene una utilidad clínica insustituible en centros especializados y unidades de hospitalización de TCA. Su repertorio de 40 ítems proporciona una exploración mucho más detallada de las conductas encubiertas (vomitar a escondidas, cortar comida en porciones milimétricas, pesaje ritual) y de la angustia moral generada por la ingesta alimentaria.

3. DIMENSIONES FACTORIALES EVALUADAS EN EL EAT-40 (GARNER & GARFINKEL, 1979)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Dieta y Restricción	20 ítems	0 a 60	Terror obsesivo a engordar, evitación rígida de hidratos, cálculo calórico y deseo de adelgazar.
2. Conducta Bulímica y Purgas	8 ítems	0 a 24	Atracones periódicos de comida, vómitos autoinducidos y preocupación culpable constante.
3. Control Oral y Presión Social	7 ítems	0 a 21	Lentitud forzada al comer, rituales de masticación y sentimiento de vigilancia externa.
4. Preocupación por la Comida	5 ítems	0 a 15	Pensar continuamente en alimentos, cocinar para otros sin comer y coleccionar recetas.
PUNTUACIÓN TOTAL EAT-40	1 al 40	0 a 120	Índice multidimensional exhaustivo de gravedad de patología alimentaria.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excepcional fiabilidad: coeficientes alfa de Cronbach de 0.91 a 0.94 en muestras clínicas de pacientes con TCA diagnosticadas en España (Castro et al., 1991; Toro et al., 1989).
Rendimiento Diagnóstico	Para el punto de corte estándar <i>ge30</i> : sensibilidad del 85% y especificidad del 92% para discriminar casos clínicos de TCA respecto a controles sanos.
Validez Concurrente	Correlación muy elevada con la puntuación global del EDI (Eating Disorder Inventory $r = 0.85$) y con el Test BITE de Bulimia de Edimburgo ($r = 0.76$).
Estabilidad Temporal	Elevada confiabilidad test-retest $r = 0.86$ a las 4 semanas en pacientes ambulatorias sin variación de peso.
Sensibilidad Terapéutica	Demuestra gran valor para monitorizar la respuesta clínica durante programas de realimentación y psicoterapia en hospitalización.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PONDERACIÓN CLÍNICA

Las respuestas a los 40 ítems se gradúan en 6 alternativas referidas al comportamiento habitual:

- **Corrección de Ítems Directos (38 ítems):**

Nunca = 0 | Casi nunca = 0 | A veces = 0 | A menudo = 1 | Muy a menudo = 2 | Siempre = 3

- **Ítems Invertidos (ítems redactados en sentido positivo, p. ej., ítem 18 y 19):**

Siempre = 0 | Muy a menudo = 0 | A menudo = 0 | A veces = 1 | Casi nunca = 2 | Nunca = 3

- **Puntuación Total EAT-40:** Suma de las puntuaciones ponderadas de los 40 reactivos. Rango: **0 a 120 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (GARNER & GARFINKEL, 1979; CASTRO ET AL., 1991)

Estrato	Puntuación	Estado de Riesgo	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	0 a 19	Actitudes alimentarias normales	Comportamiento nutricional y afectivo dentro de parámetros adaptativos. Autocuidado.
Subclínico	20 a 29	Preocupación estética / Zona limítrofe	Insatisfacción corporal relevante o conductas de dieta. Psicoeducación nutricional preventiva.
Clínico	30 a 44	Corte Positivo para TCA (≥ 30)	Alta sospecha diagnóstica de Anorexia o Bulimia. Derivación a salud mental y examen médico.
Grave/ Severo	45 a 120	TCA Severo / Incapacitante	Patología alimentaria grave con alto riesgo somático. Tratamiento especializado intensivo.

COMPARABILIDAD CON EAT-26: Existe una correlación de $r = 0.98$ entre las versiones de 40 y 26 reactivos. Mientras que el EAT-26 utiliza el umbral de 20 puntos, el EAT-40 establece su corte tradicional en 30 puntos, conservando una correspondencia clínica casi perfecta.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y TRABAJO EN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PUNTUACIONES *ge30*:

- **Paso 1 (Exploración Física Inmediata):** Registrar peso, talla, IMC, tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura; solicitar analítica urgente con ionograma completo y ECG de 12 derivaciones.
- **Paso 2 (Análisis Cualitativo de Ítems de Purga):** Revisar reactivos de vómitos forzados y uso de diuréticos/laxantes; la positividad exige reposición hidroelectrolítica prioritaria antes de cualquier intervención psicológica.
- **Paso 3 (Plan Terapéutico Multimodal):** Coordinación entre Médico de Familia/Pediatra, Psiquiatra, Psicólogo Clínico y Nutricionista para estructurar el contrato terapéutico de comidas y peso diana.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Paciente: Mujer de 21 años, estudiante de Derecho, derivada por Medicina Interna tras detectarse erosión severa del esmalte dental en cara palatina de incisivos y tumefacción dolorosa bilateral de glándulas parótidas. Refiere pérdida del control con la comida.

Resultados EAT-40:

- **Puntuación Total: 58/120 (Rango Severo — Corte Positivo).**
- **Desglose factorial:** Factor Bulimia y Purgas = 21/24 (puntuaciones máximas en atracones nocturnos y vómitos inducidos diarios); Factor Dieta = 28/60 (saltarse comidas durante el día como compensación); Preocupación por comida = 9/15.

Conducta Asistencial: Se diagnostica Bulimia Nerviosa Purgativa Grave (DSM-5). Se inicia pauta farmacológica con fluoxetina 60 mg/día (dosis específica para bulimia) y terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica de Fairburn centrada en el registro de desencadenantes de atracones y normalización de 5 ingestas pautadas al día. A las 12 semanas, la frecuencia de atracones y purgas se redujo a cero, y la puntuación en el EAT-40 descendió a 18/120 (rango no clínico).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y COMPLICACIONES MÉDICAS

ALERTA: PARO CARDÍACO POR PURGAS

Los vómitos autoinducidos repetitivos provocan hipopotasemia severa y alcalosis metabólica, con riesgo inminente de arritmias cardíacas fatales (torsades de pointes) y muerte súbita.

SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

En pacientes anoréxicas con desnutrición severa, la reintroducción rápida de calorías puede provocar hipofosfatemia aguda letal y colapso cardiopulmonar; requiere supervisión hospitalaria.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1979). The Eating Attitudes Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. *Psychological Medicine*, 9(2), 273–279.
2. Castro, J., Toro, J., Salameiro, M., & Guimerá, E. (1991). The Eating Attitudes Test: Validation of the Spanish version. *Psychological Assessment*, 3(3), 343–352.
3. Toro, J., Castro, J., García, M., Pérez, P., & Cuesta, L. (1989). Eating attitudes, sociodemographic factors, and body shape of adolescent girls in Spain. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 28(1), 61–65.
4. Guimerá, E., & Torrubia, R. (1987). Adaptación del Eating Attitudes Test (EAT) a una muestra de población española. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 14, 184–192.